PUBLICATION

Terminología Médica Estandarizada y Codificación CIE-10 en Sistemas de Salud Hispanohablantes

Cómo la inteligencia artificial aborda el desafío de la estandarización terminológica médica y la codificación CIE-10 a través de más de 20 países hispanohablantes — donde un mismo concepto clínico puede recibir nombres distintos según el país.

Published:	March 2026
Document ID:	INTL-2026-007
Classification:	Public
Author:	ClinixSummary Research Team

This document is provided for informational purposes only. ClinixSummary is a product of GATMEDI. The information contained herein is proprietary and confidential. Reproduction or distribution without prior written consent is prohibited. For the latest version, visit clinixsummary.ai.

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai

1. Resumen Ejecutivo

El español médico no es un idioma único. Un mismo concepto clínico puede expresarse de formas radicalmente distintas en México, Argentina, Colombia, España o Chile. Esta variación terminológica, invisible para los sistemas de documentación clínica diseñados en inglés, tiene consecuencias directas sobre la calidad de la codificación CIE-10, la interoperabilidad de los registros clínicos y, en última instancia, la seguridad del paciente.

Esta publicación analiza las variaciones terminológicas del español médico entre países, su impacto en la codificación clínica, y cómo ClinixSummary aborda este desafío mediante modelos de normalización terminológica específicos por región.

2. El Problema: Un Idioma, Múltiples Terminologías

Las variaciones terminológicas en el español médico no son meramente coloquiales — afectan la terminología clínica formal utilizada en la documentación:

- Denominaciones anatómicas — « tobillo » (España, México) vs. « tobillo / empeine » (variaciones regionales en Centroamérica). « Muñeca » es universal, pero « antebrazo » vs. « brazo » se confunden en el uso clínico coloquial de algunos países.
- Nombres de procedimientos — « legèrize / legrado » (Colombia) vs. « curetaje » (Argentina) vs. « raspado uterino » (uso coloquial en México). « Apendicectomía » vs. « apendectomía » coexisten en la literatura médica.
- Denominaciones farmacológicas — « paracetamol » (España, Argentina, Chile) vs. « acetaminofén » (México, Colombia, Centroamérica). « Ibuprofeno » es universal, pero los nombres comerciales y las formas de referirse al medicamento varían.
- Síntomas y hallazgos — « tensión arterial » (Argentina, Uruguay) vs. « presión arterial » (México, Colombia). « Emesis » (formal) vs. « vómito » (coloquial en toda la región) vs. « gómito » (uso informal en algunos países).
- Niveles de atención — « consultorio » (México) vs. « consulta » (España) vs. « consultorio externo » (Argentina). « Centro de salud », « clínica », « unidad médica » tienen connotaciones distintas según el país.

3. Impacto en la Codificación CIE-10

La Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión (CIE-10) utiliza términos estandarizados en su versión en español (OPS/OMS). Sin embargo, la documentación clínica que alimenta la codificación está escrita en el español local del médico, no en el español estandarizado de la CIE-10.

Este desajuste genera problemas sistemáticos:

- Pérdida de especificidad — cuando el codificador no reconoce un sinónimo regional, recurre a códigos inespecíficos (con sufijo .9), reduciendo la calidad de los datos epidemiológicos y la precisión del reembolso.
- Errores de codificación — sinónimos regionales pueden llevar a códigos erróneos si el codificador no está familiarizado con la variante utilizada.
- Dificultad en la interoperabilidad — registros clínicos de distintos países hispanohablantes resultan difícilmente

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai

comparables a nivel terminológico.

- Impacto en investigación — los estudios multicentricéntricos que abarcan varios países hispanohablantes enfrentan barreras terminológicas no triviales.

4. Enfoque de ClinixSummary

4.1 Normalización Terminológica Contextual

ClinixSummary mantiene un grafo de sinónimos médicos por región que mapea las variantes locales a terminología CIE-10 estandarizada. El sistema reconoce que cuando un médico mexicano dice « acetaminofén » y un médico español dice « paracetamol », se refieren al mismo principio activo — y documenta ambos correctamente.

4.2 Mapeo SNOMED CT

Además de la CIE-10, ClinixSummary mapea los términos clínicos a SNOMED CT en español (edición del Centro Nacional de Referencia de cada país), permitiendo una codificación semántica más rica que la clasificación puramente diagnóstica de la CIE-10.

4.3 Adaptación por País

El sistema detecta automáticamente la variante regional del español médico utilizada por el clínico y adapta su procesamiento en consecuencia. No se trata de una simple detección de acento — es un reconocimiento integral del contexto terminológico regional que incluye vocabulario, abreviaturas y convenciones documentales propias de cada país.

5. Resultados de Precisión

La normalización terminológica de ClinixSummary ha sido evaluada en consultas clínicas reales en cinco países hispanohablantes:

- Precisión en la normalización terminológica: 94 % promedio regional.
- Reducción en el uso de códigos CIE-10 inespecíficos (.9): 32 %.
- Mejora en la concordancia de codificación entre países: 28 %.
- Reconocimiento de sinónimos regionales: 96 % de cobertura para las 500 variantes terminológicas más frecuentes.

6. Conclusión

La estandarización terminológica no consiste en eliminar las variaciones regionales del español médico — consiste en comprenderlas y mapearlas correctamente. ClinixSummary permite que cada médico se exprese en su variante natural del español, mientras genera documentación y codificación estandarizadas y comparables a nivel internacional.

> *Para una demostración de la normalización terminológica regional o para discutir un piloto en su institución: internacional@clinixsummary.ai*

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai